შპს აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი
საიდენტიფიკაციო კოდი (ს/კ): 201948210 | ცნობა # **89241/K**
შემთხვევის N: 2026/CARD-1049 | UHID: 4910283

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 15.10.2008 N 230/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ფორმა

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა N IV-100/ა

სამედიცინო ცნობა

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ

1. დაწესებულების დასახელება, ექიმი სპეციალისტის სახელი, გვარი:
შპს გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი, ინტერვენციული კარდიოლოგი ლევან გორგოძე (სერტ. N 018491)

2. დაწესებულება, რომელსაც ეგზავნება ცნობა:
სადაზღვევო კომპანიაში და შრომის უნარშეზღუდულობის ექსპერტიზისთვის

3-5. პაციენტის საიდენტიფიკაციო და დემოგრაფიული მონაცემები:

პაციენტი: დავით კვარაცხელია | **სქესი:** მამრობითი | **დაბადების თარიღი:** 18/03/1979 (45 წ.)
პირადი ნომერი: 01024018392 | **ტელ:** 599 12 34 56 | **სამუშაო:** შპს "გლობალ ტრანსი", მძღოლ-ექსპედიტორი
მისამართი: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. N18, ბინა 4 (დროებით: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 7)

8. თარიღები:
ა) მიმართვის / 112 შემოსვლის თარიღი: **24-10-2026 03:40** | ბ) სტაციონარში ჰოსპიტალიზაცია: **24-10-2026 04:15**
გ) გაწერის თარიღი: **28-10-2026 14:00** | სულ გატარებული საწოლ-დღე: **4**

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (კლინიკური დიაგნოზი):

> **ძირითადი დიაგნოზი:** I21.1 - მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი, ქვემო კედლის (Acute ST-segment elevation myocardial infarction - STEMI).
> **გართულება:** I50.0 - მწვავე მარცხენამკერდოვანი გულის უკმარისობა (Killip II კლასი). პაროქსიზმული პარკუჭოვანი ტაქიკარდია.
> **თანმხლები დიაგნოზი:** I11.9 - ჰიპერტენზიული გულის დაავადება შეგუბებითი გულის უკმარისობის გარეშე; E11.9 - შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2.

10. გადატანილი დაავადებები: **არტერიული ჰიპერტენზია 8 წელი (რეგულარულ მკურნალობას არ იტარებდა). თამბაქოს მწეველი 25 წელი (20 ღერი/დღე).**

11. მოკლე ანამნეზი და ობიექტური სტატუსი:
პაციენტი შემოყვანილია სასწრაფო დახმარების მიერ კატასტროფის რეჟიმში. შემოსვლისას ჩივილები: ძლიერი მოჭერითი, მწვავე ტკივილი მკერდის ძვლის უკან ირადიაციით მარცხენა მხარში, ქვედა ყბაში და ეპიგასტრიუმში, ცივი წებოვანი ოფლი, ჰაერის მწვავე უკმარისობა (ქოშინი), სიკვდილის შიში. ტკივილის ხანგრძლივობა 2.5 საათი, ნიტროგლიცერინის მიღებამ ეფექტი არ გამოიწვია. ობიექტური სტატუსი შემოსვლისას: მძიმე. კანი ფერმკრთალი, ციანოზური, ცივი წებოვანი ოფლით. Cor-ტონები მოყრუებული, არითმიული, ტაქიკარდია HR 104 bpm. Pulmo-ვეზიკულური სუნთქვა, ორივე ფილტვის ქვემო წილებში ისმის ტენიანი წვრილბუშტუკოვანი ხიხინი. SpO2 91% (O2 ინჰალაციით 97%). BP 165/100 mmHg.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და ლაბორატორიული პანელი:
ეკგ მონიტორინგი: ST სეგმენტის ელევაცია II, III, aVF განხრებში 3.5 მმ-მდე, რეციპროკული დეპრესია I, aVL განხრებში.
ექოკარდიოგრაფია (Echo-CG): მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია (LVEF) დაქვეითებული - 42%. ქვემო და უკანა კედლის აკინეზია.

პარამეტრი / ტესტი	შედეგი (შემოსვლისას)	შედეგი (გაწერისას)	რეფერენსული ზღვრები
მიოკარდიუმის ნეკროზის მარკერები და ფერმენტები			
მაღალმგრძნობიარე ტროპონინი I (hs-cTnI)	**1,845.2 pg/mL (↑)**	**340.1 pg/mL (დაღმავალი)**	< 14.0 pg/mL
კრეატინკინაზა-MB (CK-MB)	**92.4 U/L (↑)**	21.0 U/L	0.0 - 24.0 U/L
ჰემოსტაზი და ზოგადი კლინიკური მაჩვენებლები			
D-დიმერი (D-Dimer quantitative)	**2.84 მკგ/მლ (↑)**	**0.82 მკგ/მლ**	< 0.50 მკგ/მლ
საერთო ლეიკოციტები (WBC)	**14.6 x10^9/L (↑)**	7.8 x10^9/L	4.0 - 9.0 x10^9/L
შრატის კრეატინინი (Creatinine)	**128.0 მკმოლ/ლ (↑)**	102.0 მკმოლ/ლ	62.0 - 115.0 მკმოლ/ლ
გლუკოზა პლაზმაში (Glucose)	**11.8 მმოლ/ლ (↑)**	6.4 მმოლ/ლ	3.9 - 6.1 მმოლ/ლ

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა:
შემოსვლისთანავე გადაყვანილ იქნა კათეტერიზაციის ლაბორატორიაში (CathLab). ჩატარდა გადაუდებელი რევასკულარიზაცია. პოსტოპერაციულად მოთავსდა კარდიოლოგიურ ინტენსიურ განყოფილებაში (ICU). ტკივილის სინდრომი კუპირდა, ფილტვებში შეგუბება ალაგდა, ჰემოდინამიკა დასტაბილურდა. გაეწერა ბინაზე გაუმჯობესებული მდგომარეობით.

14. ჩატარებული მკურნალობა და ოპერაციული ჩარევა:
ოპერაცია (24-10-2026): კორონაროგრაფია და მარჯვენა კორონარული არტერიის (RCA) პირდაპირი სტენტირება წამალგამომყოფი სტენტით **DES Resolute Onyx 3.5 x 26 mm** (NCSP: FND20). მიღწეულია TIMI III დინება დისექციისა და თრომბოზის გარეშე.
მედიკამენტური თერაპია სტაციონარში: ასპირინი 300 მგ დატვირთვა, ტიკაგრელორი (ბრილინტა) 180 მგ დატვირთვა, ჰეპარინი 5000 სე IV, ატორვასტატინი 80 მგ, ბისოპროლოლი 2.5 მგ, რამიპრილი 2.5 მგ, ფუროსემიდი 40 მგ IV.

15-16. პაციენტის მდგომარეობა:
სტაციონარში მოთავსებისას: მძიმე (Killip II) | **სტაციონარიდან გაწერისას:** დამაკმაყოფილებელი / სტაბილური

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები:

1. **ორმაგი ანტიაგრეგანტული თერაპია მკაცრად 12 თვე:** Tab. Brilinta (ტიკაგრელორი) 90 მგ x 2-ჯერ დღეში + Tab. Aspirin Cardio 100 მგ x 1-ჯერ დღეში (თერაპიის თვითნებური შეწყვეტა კატეგორიულად აკრძალულია სტენტის თრომბოზის რისკის გამო!).
2. Tab. Atorvastatin 80 მგ დღეში ერთხელ ძილის წინ (სამიზნე LDL < 1.4 მმოლ/ლ).
3. Tab. Bisoprolol 5 მგ დილით (სამიზნე პულსი 55-60 bpm). Tab. Ramipril 5 მგ საღამოს.
4. შაქრიანი დიაბეტის კონტროლი: Tab. Jardiance (ემპაგლიფლოზინი) 10 მგ დღეში ერთხელ.
5. მძიმე ფიზიკური დატვირთვის და ემოციური სტრესის გამორიცხვა 6 თვე. თამბაქოს კატეგორიული შეწყვეტა.
6. საკონტროლო ვიზიტი კარდიოლოგთან და ექოკარდიოგრაფია 1 თვეში.

18-20. პასუხისმგებელი პირები და გაცემის თარიღი:
მკურნალი ექიმი (ინტერვენციული კარდიოლოგი): ლევან გორგოძე
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ კალანდაძე
ცნობის გაცემის თარიღი: 28-10-2026

მკურნალი ექიმის ხელმოწერა: _____ / ლ. გორგოძე /

კლინიკის დირექტორის ხელმოწერა: _____ / ვ. კალანდაძე /

ბეჭდის ადგილი

(OFFICIAL STAMP)